

Patient's Name : _____

MRN : _____

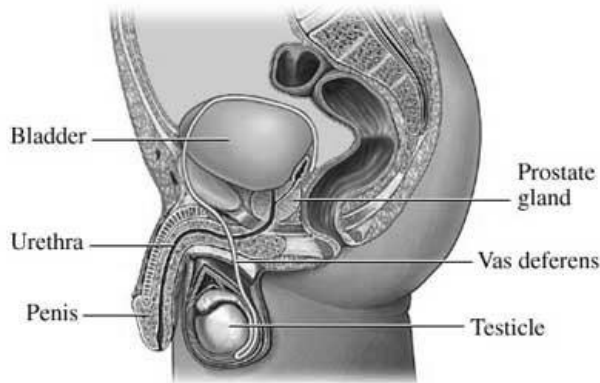
DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Transurethral Prostatectomy (TURP) & Open

معلومات الإقرار - نسخة المريض
 استئصال غدة البروستاتا بالمنظار عبر
 الإحليل & بالفتح الجراحي

1. What do I need to know about this condition?

The prostate gland is only found in males, and is situated below the bladder. The tube through which the urine passes from the bladder (the urethra), runs through the prostate, and then through the penis. Urine leaves the body through the urethra as does the semen during sexual intercourse. The main "valve" is a ring of muscle called the external sphincter which lies below the prostate gland. It controls the urinary flow.

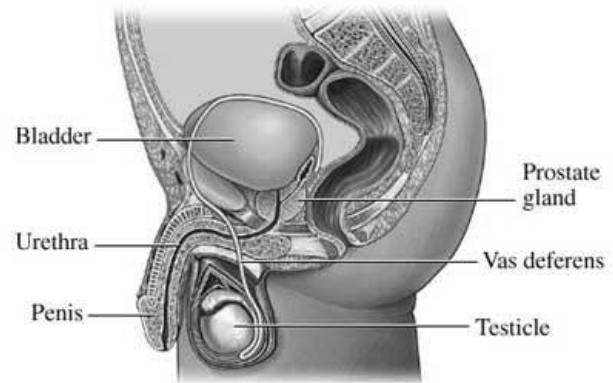


The position of the prostate gland

The prostate gland produces a milky fluid, which helps make up semen. It does not produce any hormones and there are no changes to a man's nature or secondary sexual characteristics (such as deep voice, libido etc.) following removal of the prostate.

In most men, beginning around the age of 40, there is a gradual enlargement of the prostate. This happens in varying amounts to different men. In some men, the enlarged prostate squeezes on the urethra to such an extent that it can slow the urinary

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذه الحالة المرضية؟
 توجد غدة البروستاتا عند الذكور فقط، أسفل المثانة البولية. يمر الإحليل (الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة) من خلال غدة البروستاتا ثم يمر بعد ذلك عبر العضو الذكري. يخرج البول من الجسم عبر الإحليل ، وكذلك يخرج منه أيضاً السائل المنوي عند الممارسة الجنسية. الصمام الرئيسي هو عبارة عن حلقة عضلية يسمى بالـ "العضلة العاصرة الخارجية" والتي يوجد أسفل غدة البروستاتا وتقوم بالتحكم في تدفق البول.



موقع غدة البروستاتا (صورة)

تفرز غدة البروستاتا سائل رقيق يشبه الحليب والذي يساعد في تكوين السائل المنوي. لا تنتج الغدة أي هرمون ، لذا ، فإن استئصال البروستاتا لا ينتج عنه تغيير في الطبيعة الذكورية أو في المظاهر والخصائص الجنسية الثانوية (مثل الصوت العميق ، الرغبة الجنسية الخ).

عند معظم الرجال ، وابتداءً من سن يقارب الأربعين ، يحدث تضخم تدريجي في غدة البروستاتا. يحدث ذلك بدرجات متفاوتة بين الرجال . عند بعض الرجال تسبب البروستاتا المتضخمة ضغطاً على الإحليل لدرجة التسبب في بطء جريان البول.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

stream.

When this happens, the man may have difficulty starting the urine flow and a less strength of the urinary stream.

2. What are the effects of an enlarged prostate?

Although enlargement of the prostate happens to all men, only 1 in 5 to 1 in 10 men will have problems needing surgery. These problems are:

Urinary stream

A weakening stream and difficulty in starting the urine flow. The bladder may fail to completely empty and may not feel empty even after passing urine.

Sometimes a complete blockage of the urine occurs and a tube (catheter) has to be placed through the penis into the bladder to drain the urine away. This may happen with little warning but the patient has usually had previous problems with urine flow.

Bladder effects

The effect of urinary blockage by enlarging the prostate varies between men. In some men, the bladder muscle enlarges due to the increased force needed to empty the bladder.

This causes bladder irritability and the man has to go to the toilet more frequently and may have to get up several times during sleeping hours to pass urine. An overactive bladder may also create the feeling of being unable to hold on to the urine and may cause leakage before getting to the toilet.

In other men, the bladder muscle does not enlarge but becomes stretched and under-active. The bladder does not empty completely and urine remains in the bladder even after passing urine. This can go on to cause bladder infection and stones.

عند حدوث ذلك ، قد يجد الرجل صعوبة في بدء عملية التبول ويجد ضعفاً في قوة تدفق البول أثناء خروجه.

2. ما هي آثار تضخم غدة البروستات؟

بالرغم من ان تضخم البروستات يحدث عند كل الرجال ، إلا أن فقط 1 من بين كل 5 إلى 1 من بين كل 10 من الرجال يعانون من مشاكل تتطلب الخضوع للجراحة ، وهذه المشاكل هي :

جريان البول

ضعف جريان البول وصعوبة في بدء عملية التبول . قد لا تتمكن المثانة البولية من الإفراغ الكامل لمحتوياتها من البول ، ولا يشعر المريض بأن المثانة فارغة بالرغم من قيامه بالتبول.

أحياناً ، قد يحدث انسداد كامل لجريان البول مما يستدعي وضع أنبوب (قسطرة) في المثانة من خلال العضو الذكري لتصريف وإخراج البول. قد يحدث ذلك مسبوقاً فقط بتحذيرات بسيطة تنبئ بحدوثه ، إلا أن المريض يكون قد واجه مشاكل سابقة مع جريان البول.

الآثار على المثانة البولية

يختلف تأثير انسداد جريان البول بسبب تضخم البروستاتا بين الرجال. عند بعض الرجال ، يحدث تضخم في عضلة المثانة بسبب القوة المتزايدة المطلوبة لإفراغ المثانة في مواجهة الانسداد.

يسبب ذلك تهيج المثانة مما يستدعي ذهاب المريض لدورة المياه بمعدل أكبر ، وقد يسبب اضطراب المريض لأن يستيقظ خلال ساعات نومه عدة مرات للتبول. قد يسبب فرط نشاط المثانة البولية أيضاً شعور المريض بعدم القدرة على السيطرة على خروج البول وقد تسبب تسرب البول قبل وصول المريض لدورة المياه.

عند مرضى آخرين ، لا يحدث تضخم لعضلة المثانة ولكن يحدث فيها تمدد ونقص لنشاط المثانة. لا تقوم المثانة بإفراغ البول بشكل كامل ويبقى البول في المثانة حتى بعد قيام المريض بالتبول. قد يستمر ذلك ليسبب التهاب في المثانة وتكوّن حصوات.

عند عدد قليل من الرجال ، قد يحدث أيضاً ضرر للكلى مع احتمال حدوث فشل للكلى بسبب الضغط العكسي (الارتداد) على الكلى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

In a small number of men, there may also be kidney damage and possibly kidney failure because of back pressure on the kidneys.

3. What do I need to know about the procedure?

One or more of the above problems may require the removal of the part of the prostate gland, which is causing the blockage.

Most men who have this operation do so because of the problems passing urine rather than for any medical complications.

The aim of the operation is to remove the inner part of the prostate, which is pressing on the urethra. The whole prostate is not removed and a shell of prostatic tissue will remain.

A cystoscopy (telescopic examination of the urethra, prostate and bladder) is usually performed just before the operation to help the surgeon decide which is the best operation for the patient. If the cystoscopy fails to find anything wrong with the prostate, the operation will not go ahead.

Transurethral resection of prostate (TURP)

Most prostate operations are performed using a resectoscope, an instrument that is passed along the penis into the bladder. It has a telescope and an electrical cutting attachment that enables the doctor to view the prostate and remove in small pieces the part that is causing the blockage.

Open prostatectomy

Rarely, in some patients, a TURP may not be the best surgical method to treat their enlarged prostate because the prostate gland is too large or because their urethra or bladder is too small to be able to use the resectoscope. In these cases, an open prostatectomy operation may be done through a cut in the lower part of the abdomen to remove the

في عدد قليل من الرجال قد تتطور الحالة إلى أذية في الكلى أو فشل كلوي يسبب إرجاع البول للكلية بسبب إنسداد مخرج المثانة بالبروستات المتضخمة

3. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

وجود المضاعفات السابقة أو أحدها قد يتطلب استئصال جزء من غدة البروستات المسبب للانسداد.

معظم الرجال الذين خضعوا للعملية كان بسبب المشاكل التي يواجهونها في إخراج البول وليس بسبب أي مضاعفات طبية أخرى.

الغرض من العملية هو إزالة الجزء الداخلي من غدة البروستاتا الذي يضغط على الإحليل.

لا تتم إزالة البروستات بشكل كامل ولكن يتم الإبقاء على الجزء الخارجي من نسيجها ويدعى المحفظة الخارجية.

يتم عادةً قبل العملية مباشرة إجراء تنظير الإحليل للمثانة البولية (باستخدام منظار لفحص الإحليل ، البروستات والمثانة البولية). يساعد ذلك الجراح على اختيار نوع الجراحة المناسبة والأفضل للمريض . إذا فشل تنظير المثانة في إيجاد أي خلل في غدة البروستات ، فلن يتم إكمال الإجراء.

استئصال البروستاتا عن طريق الإحليل

تتم معظم عمليات البروستاتا باستخدام "منظار القطع" ، وهو آلة يتم تمريرها من خلال العضو الذكري حتى تصل إلى داخل المثانة. تحتوي هذه الآلة على منظار تقريبي و جزء للقطع الكهربائي يمكن الطبيب من رؤية البروستاتا وإزالة الجزء المسبب للانسداد . تتم إزالة هذا الجزء على شكل قطع صغيرة.

استئصال البروستاتا عن طريق الجراحة المفتوحة.

في حالات نادرة -لا يمكن استئصال البروستات عبر الإحليل بسبب ضخامتها الشديدة ، أو بسبب مشكلة في الإحليل كالتضيقات ، أو بسبب صغر حجم المثانة مما يعيق استخدام المنظار

في هذه الحالات ، قد يتم إجراء الجراحة المفتوحة لاستئصال البروستاتا عن طريق شق جراحي في أسفل البطن لاستئصال

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

prostate.

Drugs before surgery

It is important to check with your doctor if any prescription, herbal or over-the-counter drugs you are taking are known to cause thinning of the blood as this can increase the risk of bleeding.

These drugs should not be taken for 2 weeks prior to surgery. If these drugs have been taken within the 2-week period, it may be safer to postpone the operation to avoid the increased risk of bleeding.

4. My anesthetic

This procedure will require an anesthetic.

See **About Your Anesthetic OR Epidural & Spinal Anesthesia information sheet** for information about the anesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

5. What are the benefits of having this procedure?

Most men find the problems caused by the enlarged prostate are relieved.

6. What are the risks of not having this procedure?

One in three men find that the symptoms may get worse and emergency treatment may be required if the prostate blocks the urine flow completely.

7. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return

الغدة.

تناول الأدوية قبل العملية الجراحية

من المهم أن تعرف من طبيبك إن كانت أيًا من الأدوية الموصوفة لك ، العلاجات العشبية أو أي أدوية أخرى وتتناولها دون وصفة طبية تؤدي لزيادة سيولة الدم لأن ذلك يزيد من خطر النزف أثناء وبعد العملية.

يجب عليك التوقف عن تناول هذه الأدوية قبل العملية بأسبوعين. إذا كنت قد تناولت هذه الأدوية خلال الأسبوعين الذين يسبقان العملية ، فإن قرار تأجيل العملية هو الأنسب والأكثر أماناً وسلامة لك لتفادي زيادة خطر النزف.

4. التخدير الذي أتلقيه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ ورقة معلومات التخدير المقدم لك أو ورقة التخدير النصفي (التخدير الشوكي و تخدير فوق الجافية) المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

5. ما هي فوائد الخضوع لهذا الإجراء ؟

يتخلص معظم المرضى من الأعراض التي كان يسببها تضخم البروستاتا.

6. ما هي مخاطر عدم الخضوع لهذا الإجراء ؟

عند 1 من بين كل 3 مرضى ، تتفاقم أعراض تضخم البروستات وتزداد سوءاً مما يحتم الخضوع لمعالجة طارئة إذا كانت البروستات تسبب إنسداداً كاملاً لتدفق البول.

7. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على مايلي:

مخاطر عامة:

- قد تحدث التهاب بولي ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- **Excessive bleeding.**
Blood loss during operation. This may require a blood transfusion 1 in 55.
- **Not being able to pass water (urinary retention).**
Blood clots or swelling of the bladder neck stops the flow of urine following removal of the catheter in 1 in 14 men. The catheter may be replaced until the swelling has gone down and the bleeding has stopped. Most men will then be able to urinate normally.
- **Late bleeding.**
Late bleeding up to six weeks after surgery from the operation site in 1 in 100 men. This results in blood in the urine and may block urine flow. The catheter may need to be reinserted to wash out any blood clots. A transfusion may be required. If the bleeding does not stop a further operation may be needed.
- **Bladder muscle weakness.**

العمليات لإيقافه حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).

- قد يحدث إنغلاق في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج (الفيزيائي) للصدر.
- المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المرضية، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح أو الصدر، مضاعفات قلبية أو رئوية، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من الخثرة ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- **النزف الغزير**
حدوث فقدان للدم أثناء الجراحة . يتطلب نقل الدم عند 1 من كل 55 مريض.
- **عدم القدرة على إخراج البول (احتباس البول)**
قد يؤدي وجود خثرات دموية أو تورم في عنق المثانة إلى توقف تدفق البول بعد إخراج القسطرة عند 1 من بين كل 14 مريض. قد تتم إعادة إدخال القسطرة لحين اختفاء التورم وتوقف النزيف. يتمكن غالبية المرضى بعد ذلك من التبول بشكل طبيعي.
- **النزيف المتأخر**
قد يحدث نزيف متأخر حتى بعد ستة أسابيع بعد الجراحة من منطقة العملية عند 1 من بين كل 100 مريض . يؤدي إلى تبول دموي الدم في البول وقد يسبب انسداد تدفق البول. قد تكون هناك حاجة لإعادة إدخال القسطرة لغسل وإزالة الخثرات الدموية. قد تكون هناك حاجة لنقل دم للمريض. إذا لم يتوقف خروج الدم، قد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى.
- **ضعف في عضلة المثانة البولية**

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Bladder muscle weakness may cause inability to pass urine. The catheter may need to be replaced after removal for a few days to allow the bladder muscles to recover.

• **Pain in the testicles.**

Swelling and pain in the testicles can occur due to inflammation. Treatment with rest and antibiotics.

• **Infection.**

Infection in the operation site or urinary tract occurs 1 in 20 men. Treatment will be with antibiotics.

• **Scarring of the bladder or urethra.**

A stricture (scar) can develop in the urethra or the bladder. This can slow or block the urinary flow. The scar may need stretching or cutting to allow the urine to flow freely. This scar tissue can reform and need ongoing treatment.

• **Difficulty in getting an erection.**

One in ten men find mild moderate difficulty with getting an erection after the operation. Professional counseling, advice and medications are available.

• **Retrograde ejaculation.**

The semen passes backwards into the bladder during sex rather than down the urethra in most men. This will result in reduced fertility and may affect sexual activity. There is no treatment for this. If this is an issue alternate forms of therapy should be considered.

• **Incontinence (loss of bladder control).**

Poor bladder control with urine leakage can occur following TURP. It usually improves in a few weeks but can rarely be permanent. Bladder control will usually improve with professional advice on continence management. Rarely a second operation may be necessary.

• **Injury to rectum.**

Very rarely, injury to the rectum can occur during the operation. Surgery to repair the

ضعف في عضلة المثانة البولية قد يسبب عدم القدرة على إخراج البول. قد تكون هناك حاجة لإعادة إدخال القسطرة بعد أن تم إخراجها. تتم إعادة القسطرة لعدة أيام لإعطاء فرصة لعضلة المثانة للشفاء.

• **ألم في الخصيتين**

قد يحدث ألم وتورم في الخصيتين بسبب الالتهاب. يكون العلاج بخلود المريض للراحة وتناول المضادات الحيوية.

• **الإصابة بالعدوى**

حدوث التهاب في مكان الجراحة أو في الجهاز البولي عند 1 من بين كل 20 مريض. يكون العلاج بالمضادات الحيوية.

• **وجود ندب في المثانة البولية أو الإحليل**

قد ينشأ ضيق (ندبة) في الإحليل أو عنق المثانة البولية. يمكن أن يؤدي إلى بطء جريان البول أو أن يؤدي إلى انسداد مجرى البول. قد يحتاج التضيق للتوسيع أو إلى القطع للسماح للبول بالتدفق بحرية. قد يعود التضيق مرة أخرى مما يتطلب معالجة مستمرة.

• **صعوبة الحصول على انتصاب**

عند 1 من بين كل 10 مرضى تكون هناك صعوبة بسيطة إلى متوسطة في الحصول على إنتصاب العضو الذكري بعد العملية. مما يتطلب إستشارة متخصصين بالذكورة لتقديم النصائح والعلاج

• **القذف الرجاعي:**

عند غالبية المرضى ، يحدث عند الجماع ، مرور السائل المنوي إلى الخلف ليدخل في المثانة البولية عوضاً عن مروره للأسفل إلى داخل الإحليل . يقلل ذلك من الخصوبة وقد يؤثر على النشاط الجنسي . لا يوجد علاج لذلك. إذا كان هذا الأمر يشكل هاجساً ، يمكن أخذ البدائل العلاجية الأخرى في الاعتبار.

• **سلس البول (فقدان السيطرة على المثانة البولية)**

قد يحدث ضعف في السيطرة على المثانة البولية وتسرب للبول بعد إستئصال البروستات عبر الإحليل . غالباً ما يتحسن ذلك في غضون أسابيع قليلة ، ولكنه نادراً ما يكون دائم. تتحسن السيطرة على المثانة غالباً مع تلقي المريض المشورة المتخصصة عن كيفية التعامل مع سلس البول . من النادر وجود ضرورة لجراحة أخرى.

• **حدوث إصابة للمستقيم**

أثناء العملية ، من النادر جداً حدوث إصابة للمستقيم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

injury may need a bigger cut and a longer stay in hospital. There is a possibility of temporary or permanent stoma bag to divert the faeces.

- **Increase risk in obese patients.**
Obesity increases the risk of wound infection, chest infection, heart and lung complications and thrombosis. Weight loss before surgery is beneficial.
- **Increase risk in smokers.**
Smoking slows wound healing and affects the heart, lungs and circulation. Giving up smoking before operation will help reduce the risk.
- **Death due to surgical complications of transurethral resection of prostate is about 1 in 200.**

8. What are the alternative treatments to this procedure?

Enlarged prostate - watchful waiting

This is suitable for men who have mild or moderate symptoms who feel that they can manage. They may do well for years and not need surgery.

Drug therapy

There are a number of drugs and natural therapies that can be used to help relax or shrink the prostate. However side effects including dizziness and tiredness can occur depending on the type of drug.

Trans-urethral incision of the prostate

This minor procedure is for people who have a small prostate. A small cut is made in the prostate through the urethra to enlarge the opening and improve urine flow.

Laser Prostatectomy

This is a new treatment that is currently under study and not readily available.

يتطلب الأمر جراحة أخرى لإصلاح الضرر ، مما يستدعي عمل شق جراحي أكبر وكذلك فترة إقامة أطول في المستشفى. هناك احتمال بأن يتم تحويل البراز ليخرج عن طريق فتحة خارجية مؤقتة أو دائمة للأمعاء متصلة بكيس لتجميع البراز على جدار البطن .

- **زيادة المخاطر عند ذو الوزن الزائد أو السمنة المرضية.**
مع السمنة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية. من المفيد إنقاص الوزن قبل الخضوع للجراحة.

• زيادة المخاطر عند المدخنين

يقلل التدخين من سرعة التئام الجرح ويؤثر على القلب والرئة والدورة الدموية. التوقف عن التدخين قبل الخضوع للجراحة يساهم في التقليل من هذه المخاطر.

- **الوفاة بسبب المضاعفات الجراحية لإجراء استئصال البروستاتا عبر الإحليل في حدود 1 مريض من بين كل 200.**

8. ما هي الخيارات العلاجية البديلة لهذا الإجراء؟

ضخامة البروستات والمراقبة الحذرة

و يسمح فيها بمرور الوقت قبل البدء في إعطاء العلاج ، وهو مناسب للرجال الذين لديهم أعراض مرضية بسيطة إلى متوسطة ويشعرون بقدرتهم على التعامل مع المشكلة . قد لا يواجه هؤلاء المرض أي مشاكل لسنوات ولا يحتاجون لجراحة.

العلاج بالأدوية

هناك عدد من الأدوية والعلاجات الطبيعية يمكن استخدامها للمساعدة في إرخاء البروستات أو تقليص حجمها . من الآثار الجانبية لهذه الأدوية والعلاجات الشعور بالدوخة والتعب التي قد يعاني منها المريض ، ويتوقف ذلك على نوع الدواء .

الشق الجراحي للبروستاتا عبر الإحليل

يتم هذا الإجراء الصغير للمرضى الذين لديهم غدة بروستاتا صغيرة . يتم عمل شق جراحي صغير في البروستاتا عن طريق منظار الإحليل لتكبير عنق المثانة وتحسين تدفق البول.

استئصال غدة البروستاتا باستخدام الليزر

تعد هذه من وسائل العلاج الحديثة والتي لا تزال تحت الدراسة وغير متوفرة بيسر. وهي مفيدة عند المرضى الذين لديهم خطورة في النزف وفترة إستشفاء أقصر.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

9. What do I need to know about my recovery from the procedure?

After the operation, the nursing staff will closely watch you until you have recovered from the anesthetic. You will then go back to the ward where you will recover until you are well enough to go home. If you have any side effects from the anesthetic, such as headache, nausea, vomiting, you should tell the nurse looking after you, who will be able to give you some medication to help. Your stay in hospital will probably be about 3-5 days, if you do not have any complications.

❖ Pain

You can expect to have pain in the operation site. There are a number of ways in managing your pain. You may have:

- A drip with painkillers into the spine, which deadens the area below your waist
- A drip with painkillers that you can give to yourself when you feel pain
- Tablets and injections.

It is important that you tell the nursing staff if you are having pain. Your pain should wear off within 7 - 10 days. If it does not, you must tell your Doctor.

❖ Diet

You will have a drip in your arm when you come back from surgery. This will be removed when you are able to eat and drink normally and you are no longer feeling sick. It is not unusual to feel sick for a day or two after surgery. Tell the nurse if this happens to you so that you can have drugs to stop it. To begin with, you can have small sips of water, then slowly take more until you are eating normally - this may be the evening of surgery for TURP patients but may be 1 or 2 days after surgery for men who have had open surgery.

9. ما الذي يجب على معرفته عن النقاهة بعد هذا الإجراء؟

يقوم الفريق التمريضي بتقديم العناية اللصيقة لك بعد الجراحة لحين إفاقتك من التخدير. يتم بعد ذلك نقلك مرة أخرى إلى قسم التنويم حيث تتم رعايتك حتى تكون قادراً على العودة إلى منزلك. إن كنت تعاني من أي آثار جانبية للتخدير كالصداع، الغثيان، القيء، فيجب عليك إبلاغ الممرضة المعنية بحالتك والتي سيكون بمقدورها إعطائك أدوية لمساعدتك. تتراوح فترة بقائك في المستشفى من 3-5 أيام إذا لم تظهر أي مضاعفات.

❖ الألم

توقع شعورك بالألم في موضع الجراحة. هناك العديد من الوسائل لمعالجة ما تشعر به من ألم، قد يقدم لك :

- محلول به دواء مضاد للألم في العمود الفقري، ويسبب ذلك تخديراً لمنطقة ما تحت الخصر.
- محلول به دواء مضاد للألم يمكنك إعطائه لنفسك عند شعورك بالألم. (مسكن قوي عبر الوريد)
- الحبوب و الحقن.

من المهم إبلاغ ممرضتك عند شعورك بالألم. من المفترض تناقص واختفاء الألم خلال 7-10 أيام. إذا لم يختف الألم بعد هذه الفترة، قم بإبلاغ الطبيب.

❖ الحمية

عند عودتك من غرفة العمليات، سيكون هناك محلول موصول بذراعك. تتم إزالة ذلك بمجرد مقدرتك على تناول الطعام والشراب عبر الفم وبمجرد توقف شعورك بالإعياء. ليس من المستبعد شعورك بالتعب والإعياء ليوم أو يومين بعد الجراحة. أبلغ ممرضتك إذا كنت تشعر بذلك لتتمكن من إعطائك الدواء المناسب لإيقاف ذلك. ابدأ بتناول رشفات صغيرة من الماء، ثم قم تدريجياً و ببطء بزيادة الكمية حتي تعود لتناول طعامك بشكل طبيعي. قد تعود لتناول طعامك بشكل طبيعي في نفس الليلة بعد إجراء استئصال البروستاتا عبر الإحليل، إلا أن المرضى الذين يخضعون لاستئصال البروستاتا بالجراحة المفتوحة، فقد يعودون لتناول الطعام بشكل طبيعي بعد يوم أو يومين من العملية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

❖ Bladder and urine

A tube (known as a catheter) is passed into the bladder during the operation and will remain there after surgery until any heavy bleeding has stopped. The catheter may stimulate the inside of the bladder giving a sensation of a full bladder. It may also cause spasms, which make the bladder contract and urine to leak around the catheter.

The nursing staff will check to make sure a blocked catheter is not the cause of these problems. The spasms usually go away once the catheter is removed. Irrigation may be attached to the catheter to flush the bladder and remove any clots or shreds of tissue that could otherwise block the catheter. The urine will be very bloody for 24- 48 hours after the operation.

When the catheter is removed, the urine may flow with little warning and there may be some scalding. You should pass urine when you need to and not try to hold on at this stage. Most patients will regain bladder control by the time they leave hospital. Some men may however, have some urine leakage and frequency. This usually settles after a few months but there are a few men for whom this may become a long-term problem.

Some men, who have difficulty passing urine once the catheter is removed, may have the tube replaced for a few days to a week. This usually settles although there will be a few men who will continue to have problems.

If so, they will be taught how to put a tube into their bladder to empty it until the bladder muscle regains its strength. This can be done at home and may continue for several weeks.

❖ Bowels

You may experience some difficulty with opening

❖ المثانة البولية والبول

أثناء الجراحة ، يتم وضع أنبوب (يعرف بالقسطرة) في المثانة البولية ، ويظل في موضعه بعد الجراحة لحين توقف أي نزيف شديد . قد يؤدي وجود القسطرة إلى تهيج داخل المثانة مما يعطي المريض شعوراً بامتلاء المثانة ، كما أن وجود القسطرة قد يؤدي إلى تقلصات مما يؤدي إلى انقباض المثانة وتسرب البول من حول القسطرة.

يقوم الممرض المعني بحالتك بالتحقق من أن هذه المشاكل ليست بسبب انسداد القسطرة. تختفي التقلصات عادةً بمجرد إزالة القسطرة . قد يتم توصيل القسطرة بسائل لغسل وإرواء المثانة البولية لإزالة أي جلطات أو أي أجزاء من الأنسجة التي قد تسبب انسداداً للقسطرة. تخرج كمية كبيرة من الدم مع البول لفترة ال 24 -48 ساعة التي تعقب العملية.

بعد إزالة القسطرة ، قد يخرج البول دون إنذار كاف وقد يشعر المريض بحرقان . يجب على المريض التبول كلما شعر بالرغبة في ذلك ، ولا يجب عليه منع البول من الخروج خلال هذه المرحلة. معظم المرضى يستعيدون قدرتهم على التحكم في المثانة البولية مع خروجهم من المستشفى . إلا أن بعض الرجال قد يعانون من تسرب بعض البول وكثرة مرات التبول. عادةً ما يختفي ذلك بعد عدة شهور ، إلا أنه وعند بعض الرجال ، قد تكون هذه المشكلة طويلة الأمد.

عند بعض الرجال الذين يواجهون صعوبة في إخراج البول بعد إزالة القسطرة ، قد تكون هناك حاجة لإعادة إدخال القسطرة لعدة أيام أو لأسبوع. عادةً ما يستقر ذلك ، إلا أنه وعند قلة من الرجال تستمر المشكلة ، وفي هذه الحالة يتم تعليمهم كيفية وضع القسطرة لأنفسهم في المثانة البولية لإفراغها حتى تستعيد عضلات المثانة البولية قوتها . يمكن أن يتم ذلك في منزل المريض وقد يستمر لعدة أسابيع.

❖ الأمعاء

في الأيام الأولى التي تعقب الجراحة ، قد يواجه المريض بعد

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

your bowels in the early days after surgery. This is usually treated with drugs to loosen the bowel motion. It is important to keep the bowel motions soft and regular as straining may cause bleeding.

❖ Sex

After prostatectomy, the semen does not come out of the penis immediately after ejaculation. Instead, it passes into the bladder and then is passed out with the next flow of urine. Because of this, most men will be sterile although contraception should be used with a partner who is still able to have children, as some semen may leak.

Most men, who were not having difficulty with normal orgasm and erections before surgery, should still be able to have normal orgasm and erections after surgery. Sexual intercourse should be avoided for six weeks after the surgery.

- Avoiding chest infections and blood clots.
It is very important after surgery to start moving as soon as possible. This is to prevent blood clots forming in your legs and possibly travelling to your lungs. This can be fatal.

Also, you need to do your deep breathing exercises, ten deep breaths every hour, to get the secretions in your lungs moving and help prevent a chest infection. At all costs, avoid smoking after surgery as this increases your risk of chest infection which causes coughing- a painful experience after surgery.

❖ Exercise

It usually takes about 8 weeks to recover. You should avoid driving for four weeks after surgery. Do not lift heavy weights for at least 8 weeks after surgery. This is to allow healing to take place inside.

10. What do I need to tell my doctor?

Tell your doctor if you have:

المشاكل في التبرز. يتم عادةً علاج ذلك بالأدوية الملينة لحركة الأمعاء. من المهم بقاء حركة الأمعاء ليونة ومنتظمة لأن التعب أثناء التبرز قد يسبب النزيف.

❖ ممارسة الجنس

بعد استئصال غدة البروستاتا، لا يتم خروج السائل المنوي من العضو الذكري مباشرة بعد القذف، وعوضاً عن ذلك، فإن السائل المنوي يدخل إلى المثانة، ثم يخرج بعد ذلك عندما يقوم المريض بالتبول. وبسبب حدوث ذلك فإن معظم المرضى يعانون العقم، إلا هناك احتمال تسرب بعض السائل المنوي، فإن على زوجة المريض الاستمرار في استخدام موانع الحمل إذا كانت لا تزال في سن يسمح لها بالحمل.

معظم الرجال الذين لم تكن لديهم قبل الجراحة صعوبة في الشعور بالنشوة الجنسية (ذروة العلاقة الجنسية) والانتصاب، من المفترض استمرار الشعور بالنشوة الجنسية والانتصاب لديهم بعد الجراحة. يجب تجنب المعاشرة الجنسية لستة أسابيع بعد الجراحة.

❖ تجنب الإصابة بالتهاب الصدر والجلطات الدموية، من

المهم جداً بعد الجراحة أن تمارس الحركة في أقرب فرصة ممكنة لتجنب تكوّن جلطات الدم في الساقين واحتمال وصولها إلى الرئتين مما قد يسبب الوفاة.

كما أن عليك ممارسة تمارين التنفس العميق (أخذ عشرة أنفاس عميقة كل ساعة) لتحريك الإفرازات الموجودة في رئتيك والمساعدة في منع حدوث عدوى الصدر. ومهما كان الثمن، فعليك تجنب التدخين بعد الجراحة لأن ذلك يسبب زيادة في مخاطر الإصابة بالتهاب الصدر، ويسبب السعال والذي يكون في حد ذاته تجربة مؤلمة بعد الجراحة.

التمارين الرياضية

عادةً، تستغرق فترة الشفاء حوالي 8 أسابيع. يجب تجنب قيادة السيارة لأربعة أسابيع بعد العملية. لا تحمل أوزان ثقيلة لمدة 8 أسابيع على الأقل بعد الجراحة وذلك للمساعدة في حدوث الالتئام الداخلي.

10. ما الذي ينبغي عليّ إبلاغه لطبيبي؟

أبلغ طبيبك إن كان لديك:



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Large amounts of bloody discharge from the penis.
- Fever and chills.
- Difficulty or inability to pass urine.
- Pain that is not relieved by prescribed painkillers.
- Swollen abdomen.

Notes to talk to my doctor about:

• خروج كمي كبير من الدم من الإحليل.

• إرتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة.

• صعوبة التبول أو عدم القدرة على إخراج.

• ألم لا يختفي بمضادات الألم الموصوفة.

• انتفاخ في البطن.

أمر أتناقش حولها مع طبيبي:
